جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : زينب عباس هلال السيد
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الدراسه **العنوان :** //////////
رقم البطاقة : 25509090103941 **رقم التليفون :** 01110857872 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 09-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 09-09-1955 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: زينب عباس هلال السيد
National ID: 25509090103941

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

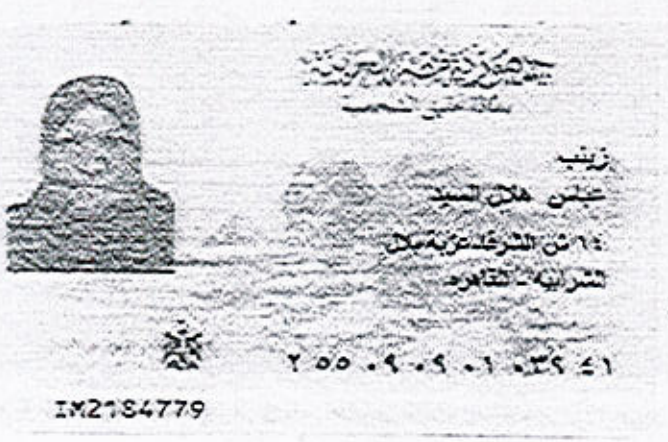
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

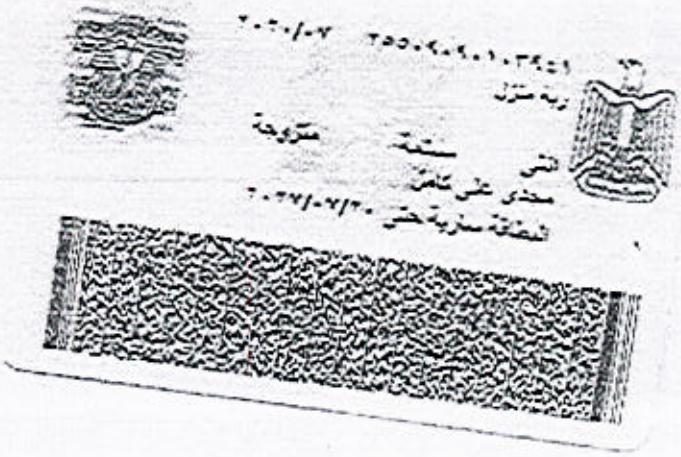
تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Further investigations and imaging**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	: الأستاذه / زينب عباس هلال السيد	Request No.	: 13009140
Patient No.	: 25509090103941	Request Date	: 06/12/2023
Path No.	: SR-1553/23	Verification Date	: 19/12/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - تغطية الدولة
Age	: 68 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

* HER2: Negative (score 0).
* Ki67: Positive in 5% of tumor cells.

Signature
Dr.Rana Fathy
Dr.Heba Hassan

Verified by :
Dr.Heba Hasan

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : زينب عباس فتح الله
Sex: Female
3- Medical number: 83176064
Old Med : 4556-2023
2-ID number: 25509090103941
Patient Age : 68 Y



Family History
Phone: 01009521541
BMI
REASON OF MDT
marital status
NRS Score
GROUP
Date of MDT: dd/mm/yyyy
Co morbidity
Menopausal status
Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :
operated outside out hospital
RT wide local excision mammography : revealed no residual lesions

Mets Workup :
CAP : FREE
still : capped wound

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
Ductal carcinoma in situ with micro invasion	8/8	8/8	0		5

T	N	M
MIC	0	

Sonomammography

PATIENT HISTORY
RT BREAST MASS :DCIS +MICROINVASION operated outside out hospital WLE WITH FLUSHED SURGICAL MARGIN
RT WIDER excsion+SLNB:high grade DCIS
free LN 0/6 , margin

MDT OUTCOME & PLAN

FOR PORT, TAM FOR 5 YEARS

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Zainab Abbas Helal Al Sayed	Date : 05/12/2023
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 40 Year(s)
Medical ID: 4556/2023	Pat. ID: 44701

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

WLE
Rec

Indication:
Post right breast WLE that proven post-operative to be IDC

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)

Right breast:

- Operative bed parenchymal distortion, air and scarring with no sizable mass
- No suspicious microcalcifications
- No sizable collection
- Mild edema pattern in the form of increased trabeculations.
- Reactive levels I & II axillary lymph-nodes showing preserved fatty hila and mild diffuse cortical thickening mostly due to post-operative inflammation.

Left Breast:

- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- No spiculated mass
- Normal retro-areola ducts
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post operative status of right breast showing no gross residual mass and axillary reactive lymph-nodes (BIRADS 6)
- Normal study of the left breast (BIRADS 1)

Best regards,
Dr. Amira H Radwan MD,
Breast Imaging consultant,
NCI, Cairo University
05/12/2023 2:56 PM

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Bur El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
مستشفى بورفؤاد
قسم الأشعة

Patient Name: Zahab Abdel Hafiz Ali Sayed | Date: 19/12/2023
Group: G [CNSS] | Age: 66 Year(s)
Medical ID: 45584/023

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

*** Reported history of right breast mass.*

Findings:

I Chest:

- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- Left upper lobe faint parenchymal veiling.
- No pathologically enlarged mediastinal lymph nodes.
- Enlarged right axillary lymph nodes, the largest at level I meausres about 1.9 x 1.2 cm in axial diameters.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Borderline cardiac size. No pericardial effusion detected.n

II Abdomen & pelvis:

- The liver is enlarged showing homogenous parenchymal attenaution. No definite focal lesions on non conrast basis.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal non contrast CT appearance of the spleen, pancreas, kidneys, both suprarenals glands.
- Averagely filled brinary bladder showing no sizable diverticular outpouching.
- Small subcentimetric bilateral extremal iliac lymph nodes.
- No ascites.

III THE EXAMINED SKELEOTN:

- *No evidence of sclerotic of lytic osseous lesions. Advanced spondylodgenerative changes.*

Oolnion:

- No definite pulmonary, hepatic or osseous deposits on non contrast basis.

Dr. Ali Elsisy, MSc
Dr. Amr Farouk, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]